

TEMA 3.9 • OBSTETRICIA

Aborto Espontáneo

PERFIL EUNACOM 2.01.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Aborto Espontáneo

Definición

Pérdida del embarazo **antes de las 22 semanas** (o antes de 500 g). Definición moderna: < 20 semanas + 6 días.

- Incidencia: ~10% de embarazos (hasta 30% si se incluyen embarazos bioquímicos)

Clasificación

TABLA 3.9.1: TIPO VS DEFINICIÓN		
TIPO	DEFINICIÓN	CONDUCTA
Amenaza / Síntomas de aborto	Dolor ± metrorragia, sin modificaciones cervicales, sin criterios de inevitabilidad	Expectante, reposo relativo, abstinencia sexual
Aborto inevitable / En evolución	Modificaciones cervicales (dilatación) u otros criterios de inevitabilidad (huevo roto, infección, desprendimiento ovular)	Hospitalizar, conducir trabajo de aborto
Aborto incompleto	Se abortó parcialmente — restos > 15 mm en útero	Conducir evacuación (fármacos o AMEU)
Aborto completo	Se eliminaron todos los restos — restos ≤ 15 mm	Observar
Aborto complicado	+ infección, hemorragia grave, CID	Manejo activo urgente
Aborto no complicado	Sin complicaciones graves	Según tipo

Manejo General

Tres opciones de evacuación (paciente decide salvo complicaciones)

TABLA 3.9.2: OPCIÓN VS CUÁNDO	
OPCIÓN	CUÁNDO
Observación (expectante)	Solo < 13 semanas, paciente dispuesta a esperar — mayor riesgo de complicaciones > 13 sem
Fármacos (misoprostol ± mifepristona)	Más usado en práctica; mejor resultado con combinación
AMEU (aspiración manual endouterina)	En complicados o cuando se requiere evacuación inmediata

NOTA CLÍNICA

En abortos **complicados** (metrorragia masiva, infección), el médico indica el procedimiento invasivo de inmediato — la paciente no elige en este caso.
> 13 semanas: No se puede optar por observación (mayor riesgo de hemorragia, CID, infección).

Medidas siempre

- **Apoyo emocional** en todos los casos
- **ROGAM** (anti-D) si madre Rh negativo — en todos los abortos que se evacuan
- **Biopsia del material** evacuado (excepto en amenaza/síntomas sin evacuación) → descartar mola + búsqueda de causa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Aborto Espontáneo: Aborto Espontáneo ## Definición Pérdida del embarazo antes de las 22 semanas (... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Aborto Espontáneo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Clasificación
- Manejo General
- Tres opciones de evacuación (paciente decide salvo complicaciones)
- Medidas siempre
- antes de las 22 semanas
- Amenaza / Síntomas de aborto

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ABORTO ESPONTÁNEO)

PREGUNTA 1

En relación a Aborto Espontáneo: Aborto Espontáneo ## Definición Pérdida del embarazo antes de las 22 semanas (... ¿cuál es la conducta correcta?

- A) El diagnóstico de Aborto Espontáneo se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Aborto Espontáneo debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Aborto Espontáneo requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Aborto Espontáneo es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Aborto Espontáneo no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Aborto Espontáneo?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Aborto Espontáneo. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: ABORTO ESPONTÁNEO

Pérdida del embarazo antes de las 22 semanas (o antes de 500 g). Definición moderna: < 20 semanas + 6 días. ::::note En abortos complicados (metrorragia masiva, infección), el médico indica el procedimiento invasivo de inmediato — la paciente no elige en este caso.